# פגישות עם האחר:
# המסר שבמילה שלא נאמרת

רות אל־רז ומרשה לוין שבירו

## חלק א | רות אל־רז

כמטפלות, אנו רואות בכל יום נשים במצוקה רגשית; כפמיניסטיות, הגענו לכלל הבנה שחלק גדול מכאבן נובע מההתנגשות שבין הצרכים הפרטיים שלהן ובין הנורמות החברתיות הקיימות.

כמי שמשתייכות לארגון טיפולי פמיניסטי, אנחנו, כותבות המאמר, עובדות בתוך הקשר פוליטי/חברתי, ולכן, בכל מפגש שומעת המטפלת שתיים או שלוש נעימות: היא מקשיבה לערכים החברתיים של הקהילה, כפי שהופנמו על ידי המטופלת, לדרך שבה המטופלת מבינה את המציאות שלה, והיא מקשיבה לקול הפנימי שלה עצמה. איך ומתי משתלבות הנעימות האלה בהרמוניה?

כאשר המטפלת בת המעמד הבינוני מקשיבה למטופלת בת אותו מעמד, בדרך כלל אין כמעט דיסונאנס בין שתי התפיסות של החומר המילולי. שוב, ההנחה היא ששתי הנשים שותפות לרוב הערכים של החברה שלהן, אף שהנחה זו עלולה להיות שגויה. ואולם, יש להניח שהמטפלת מודעת לעולם הפנימי שלה ולקונפליקטים שבין צרכיה לבין תביעות החברה, ובנוסף לכך, יש לה את היכולת ואת האחריות לבדוק את עצמה כשתפיסתה של המטופלת עומדת בניגוד לתפיסתה היא.

**זמן מה לאחר שהתחלנו בטיפול, נהייתי מודעת ל"יסוד החסר" - למה שלא נאמר בינינו. אף מילה לא נאמרה על העובדה שאנחנו נמצאות משני עברי המתרס של מאבק לאומי.**

בדיקה עצמית כזו נחוצה מאוד כאשר המטופלת מייצגת את ה"אחר", בין אם מדובר במעמד חברתי אחר, קבוצה אתנית אחרת, או ב"אחר" שהוא המוקד העיקרי של מאמר זה, דהיינו, הזהות המינית ה"אחרת". הדבר חשוב במיוחד כאשר המטופלת, בשונה משתי כותבות מאמר זה, אינה משתייכת לקבוצה השלטת בחברה, ואינה מקיימת את אורח החיים שלה. בישראל בת זמננו, קבוצה זו היא עדיין קבוצת המעמד הבינוני, היהודי, האשכנזי וההטרוסקסואלי.

כמטפלות פמיניסטיות בעלות מודעות פוליטית, אנחנו מניחות שאנו חפות מרגשות הומופוביים סמויים ומהפחד מהשונה מאתנו מינית, למרות העובדה שאנו חיות בחברה שהיא ברובה הומופובית. אנחנו גם מניחות שבאופן כללי ההטיות והדעות הקדומות שלנו מזעריות, אף שאנו חיות בחברה המתבססת במידה רבה על חשיבה סטריאוטיפית. נכון שאנו משוחררות מחשיבה סטריאוטיפית יותר מרוב התושבים, אבל לא משוחררות מ... התחלתי להבין שרבות ממגבלותיי האישיות מתגלות בשימוש שלי במילה שלא נאמרת. להלן שתי נקודות מבט על המילה שלא נאמרת.

המטפלת: "אם אגיד ... היא תחשוב שאני רואה אותה כערביה, כתימניה, כלסבית – כחלק מקבוצה, כאובייקט. אולי כדאי לא להעלות את הנושא עד אשר היא תעלה אותו בעצמה."

המטופלת: "למה היא לא יכולה להרגיש שיש לי בעיה לדבר על זה שאני לסבית? אולי השתיקה שלה מעידה על אי־נוחות מהנושא?"

בכל פעם שמישהו ניצב מול "האחר" הוא עשוי לראות את "האחר" כאובייקט; עצם ההתייחסות ל"אחר" כאובייקט מעבירה את הצופה אל מקום בטוח מבחינה רגשית.



נסרק עם CamScanner

## תאורי מקרים

■ מַרים, ישראלית מוסלמית, נמצאת בטיפול אצלי, מטפלת ישראלית יהודיה, הרואה את עצמה כאדם פתוח וליברלי. מערכת היחסים שלנו היתה חיובית וחמה, והרגשתי קבלה הדדית. ואולם, זמן מה לאחר שהתחלנו בטיפול, נהייתי מודעת ל"יסוד החסר" – למילה שלא נאמרה. אף מילה לא נאמרה על העובדה שאנחנו נמצאות משני עברי המתרס של מאבק לאומי. מבלי לחשוב על כך, הנחתי שהיא יודעת שאני "לצדה", אך מעולם לא לקחתי בחשבון את האפשרות, שדעותיה שונות משלי, ואפילו יותר מזה, שונות מהסטריאוטיפ שלי בקשר למה שצריכה לחשוב ישראלית מוסלמית. כאשר גיליתי מה היה "חסר" העליתי את הנושא: "אני יהודיה, את מוסלמית. האם זה חשוב או לא?" היא אמרה שהיא שיערה שהעמדות החברתיות/פוליטיות שלי הן כאלה שיקבלו אותה, אך הרגישה חוסר נוחות בדיוק בשל עובדה זו. היא רצתה שאראה אותה "כאדם פרטי, ולא כמייצגת קבוצה מסוימת". היא גם אמרה שהיו היבטים באישיות שלה שאותם היססה להעלות, כדי שלא לאכזב אותי לגבי התדמית שלה, כפי שהניחה שהצטיירה בעיני. לאחר שנושא זה הובהר, יכולנו לחזור לתחום האישי, לאותן בעיות גדולות וקטנות שמרכיבות את ההוויה האנושית.

במערכת היחסים בין מטפלת הטרוסקסואלית למטופלת לסבית עשויות להתעורר השלכות דומות של ציפיות. המטפלת ההטרוסקסואלית הפמיניסטית, שהיא בעלת כוונות טובות, עשויה לקבל כפשוטה את הקביעה של המטופלת: "אני לסבית ואין צורך לדון בנושא."

■ רחל היא בוגרת אוניברסיטה בת עשרים ושמונה. היא התלוננה על קשיים ביצירת קשרי ידידות ובחירת מקצוע, וגם הביעה רצון להיות קרובה יותר להוריה. אף שהיו לה שלוש מערכות יחסים אינטימיות עם גברים, היא דיברה על העדפה של יחסים עם נשים. היא לא התייחסה לכך כאל בעיה, למרות העובדה שרק קומץ חברות לסביות קרובות ידעו על ההעדפה המינית שלה. קיבלתי את מה שאמרה: "אני מעדיפה נשים – ואין צורך לדבר על הנושא." המוזר הוא, שלא עלה בדעתי באופן מודע לערער על קביעה זו בשלב מאוחר יותר, כפי שהייתי עושה בנושא אחר, טעון פחות. כל מטפלת מיומנת היתה, ודאי, מציינת לעצמה שיש לחזור לנושא בעתיד, כשהמטופלת תגלה נכונות לדון בו. כמו במקרה של מרים, לאחר שבנינו מערכת יחסים פתוחה, נוכחתי לדעת שהמילים שאינן נאמרות תופסות נפח רגשי. הבנה זו אפשרה לי להתעמת עם מה שהיה חסר. למרות ההצהרה הפותחת של רחל, היא היתה גאה בעובדת היותה לסבית, אך לא שלמה אתה; היא אפילו לא יכלה לומר את המילה "לסבית" ביחס אל עצמה, אף שהשתמשה בה בגאווה כאשר דיברה על חברותיה. היא היתה זקוקה לאישור שאני יכולה לקבל אותה באמת ובתמים, לפני שיכלה לדבר איתי על הפחדים שלה מחיים הומוסקסואליים, ויותר מכול, על הכאב שתגרום להוריה. בהתחלה היא ראתה בי תחליף הורי, ונזקקה לתחושה של אישור שלי, ורק לאחר מכן היא יכלה להתמודד עם הוריה במפגשים שלנו.

אני מאמינה, שאינני המטפלת היחידה שמדי פעם עושה שימוש לא נכון במילה שלא נאמרת, ובמקרה זה המילה היא "לסבית". אבל מדוע זה קורה? האם לעתים אנו כה חוששות מההומופוביה המופנמת שלנו, שגישה ישירה בנושא ההעדפה המינית של המטופלת נראית לנו נגועה במציצנות? או שמא אנו רואות את המטופלת כ"אובייקט", כפי שכבר נאמר קודם?

בכל פעם שמישהו עומד מול ה"אחר" קיימת האפשרות לראות את ה"אחר" כאובייקט; באופן זה



נסרק עם CamScanner

מרעבר הצופה למקום רגשי מרוחק ובטוח יותר; הדבר עשוי להיות נכון גם כשמדובר במטפלת. עם זאת, בעצם השאיפה שלנו להיות "אובייקטיביות", כלומר, להתייחס למטופלת שהיא ה"אחר" ללא רעות קדומות, אנחנו עלולות לשקף לה תמונה חיובית יותר מזו שהיתה משקפת לה מטפלת "כמותה".

ייתכן גם שהמטופלת והמטפלת יקשרו ביניהן קשר של שתיקה בכך שלא יתעמתו עם ההומופוביה של המטופלת עצמה, לדוגמה, כאשר זו עומדת על כך שהמטפלת שלה תהיה הטרוסקסואלית. אני מאמינה שלסבית/סטרייטית הוא שילוב מצוין, אבל אם המטופלת מתעקשת על שילוב כזה, ייתכן והדבר מצביע על בעייתיות מסוימת בזהות עצמית.

עד עכשיו כללתי את כל ה"אחרים" תחת כותרת אחת. אמנם בישראל, הלסביות בדרך כלל שונות, בכך שהן אינן מוגדרות כישות נפרדת על ידי צורה מסוימת, גודל או צבע. "האחר" באשה המרגישה את עצמה לסבית או מגדירה את עצמה כלסבית יכול להיראות לעין או לא, על פי בחירתה. "יציאה מהארון" היא חשיפה עצמית מתוך בחירה, רצון להיראות, לחגוג את מציאת הזהות שלה, הצהרה לעולם על היותה "שונה". המטפלת היא, פעמים רבות, שותפה לתהליך ההחלטה, וככזו היא חייבת להיות מודעת היטב לחלקים מהווייתה המעורבים בתהליך, אולי לא תמיד מרצונה.

הרגשתי אמפתיה למטופלות שלי, אמפתיה ל"אחר" או ל"אאוטסיידר" שבהן. גדלתי כבת יחידה וביישנית, יהודיה בפרבר נוצרי של לונדון, ואחר כך עברתי לישראל, בה אני מרגישה כאנגלוסקסית תמידית, ומה יכול להיות "אחר" יותר מזה?

מידת האמפתיה המורגשת כלפי כל מטופלת משתנה, כמובן, ממטפלת למטפלת. אולם, אני חשה, שאם המטפלת עצמה היא "אחר", במידה זו או אחרת, יהיה הצמד הטיפולי קל יותר וקשה יותר בו זמנית. תוך כתיבת מילים אלה, אני גם מבינה שכל אחד ואחת מאתנו חשים את עצמנו בתקופות שונות בחיינו כ"שונה", ואולי זהו היבט מרכזי של להיות "עם" המטופלות שלנו, היבט שיש להמשיך ולחקור בטיפול.

## חלק ב: מרשה לוין שבירו

ישבתי מצדו האחד של השולחן ומעברו השני ישבה ליאורה (בת 48, גרושה מזה שנתיים). היא מחזיקה בידה תה צמחים, ואני כוס מרק צח אינסטנט רווי מונוסודיום גלוטמט, הכיסאות שלנו נטויים בזווית קלה לכיוון הקיר, רגלינו עטויות מכנסי ג'ינס כהים ואחידים, כפות רגלינו נתונות בנעלי הליכה מגושמות ודומות, אני בסוודר ורוד מצויץ ודהוי ועונדת עגילי פנינה קטנים, היא בחולצה "גברית" בצבע אפור, ללא עגילים. כשמדובר בליאורה, פרטים אלה נראים לי משמעותיים. זהו ביטוי אחד בנושא הנסתר של קוטביות ודמיון, שעולה במפגש עם המטופלת הלסבית שלי: אשה־אשה; אם־אם; הטרוסקסואלית־לסבית; סטריאוטיפ נקבי־סטריאוטיפ זכרי.

ליאורה דיברה על רגשות של כאב, השפלה – סלידה מעצמה על שחשפה את המשיכה הגופנית שלה למישהי, ושוב הזמינה דחייה. התגובה האדישה לתשוקתה המינית החזירה לחיים טראומה "גנטית". כשהיתה בת תשע ואמה אושפזה בבית חולים בגלל מחלת הסרטן, התעלל בה אביה מינית. אף שיש לה רק שברי זכרונות, הרגשות הנלווים אליהם צצים ועולים בצורתם המקורית והבלתי



נסרק עם CamScanner

מעובדת. היא היתה משוכנעת שהיה בה בגיל תשע משהו דוחה מולד, שמנע מאחרים מלאהוב אותה, ואשר ביטויו כיום גורם לה להיות דחויה מינית, אם כי בצורה מוגבלת יותר. הטיפול שלנו התמקד ברגשותיה בהווה ובקשר שלהם לניסיונות העבר שלה. היא חשה זעם על העוול שנעשה לה, ועל כך שהיא עצמה הפנימה אותו והפכה אותו לדימוי העצמי ה"דוחה" המעוות שלה.

בעוד שבמישור אחד היתה בי אמפתיה לכאב שלה ועזרתי לה לעבד אותו, במישור אחר מצאתי את עצמי מצטטת "סטטיסטיקות של חיזורים" ו"אחוזים" – ואומרת לה כמה "צפרדעות" היא תצטרך עוד לנשק עד שתמצא את "הנסיכה" שלה (אני קצת נרתעת מהביטוי הנדוש והמתחנחן הזה אך בכל זאת השתמשתי בו) כדי להדגיש את הנקודה, ששלוש דחיות אינן מהוות הוכחה חד־משמעית לכך שהיא דחויה... וכך נמנעת ממנה האפשרות להתחבר לחוויה של הילדה בת התשע בכל דרך, חוץ מאשר דרך ההשלכות המזיקות שלה.

אבל לאורך כל המפגש חוויתי הבזקים רבים של עצמי במצבים כואבים שונים: כאחות השקטה במשפחה דברנית מאד, כפסיכולוגית האמריקנית החדשה במרפאה לבריאות הנפש, שבה חשתי עוינות, או לפחות חוסר הערכה כלפי. הרגשתי שאף אחד לא יוכל לראות אותי מעבר לעברית ההססנית שבפי, מעבר לדמות של המהגרת בהתגלמותה.

נמנעתי מלחוות מחדש את הרגשות והחששות של תחושת אי־השייכות: להיות חריגה במלוא מובן המילה. כמטפלת, נשארתי עם ליאורה בזירה הרומנטית/מינית, מתחמקת מהסוגיה החשובה יותר של השייכות. רגשותיה של ליאורה – בין אם היו אובייקטיביים או סובייקטיביים – היו רגשות של שונות, של חוסר מקובלות על האחרים, ונבעו מהילדות ומההקשר החברתי־תרבותי העכשווי של לסבית בארון, כאן, בישראל. הרגשות האלה הציתו את הכאב הישן שלי. ייתכן שחוסר הרצון שלי להיות "דומה" למישהי שאינה שייכת לזרם המרכזי, שיקף גם את חוסר הרצון שלה לצאת מהארון, גם בגלל הפחד מדחייה. החשש אינו השלכה דמיונית של רגשות אי־ההתאמה שלה, אלא קריאה נכונה של מעמד הלסביות בישראל. ייתכן שנמנעתי מההתמודדות עם הסטיגמטיזציה האמיתית של הלסביות בחברה הישראלית והבלבול הנובע ממנו בשאלה, למי שייכים החלקים "המלוכלכים" או "הדוחים" – האם מדובר בהשלכה חברתית (הומופוביה), או באמת בחלק מהזהות העצמית?

אף שאני מאמינה שבמודע איני הומופובית, הפחדים הלא־מודעים שלי מלהיות שונה, ולכן דחויה, הם אלה שגרמו לי להתעלם מחלק חיוני של הדימוי העצמי של ליאורה – לא רק הפנמת הילדה שסבלה התעללות ונטישה, והאשימה את עצמה בכך, אלא גם הלסבית המתמודדת עם "הגועל נפש" החברתי והתרבותי, ועם הסלידה שלה עצמה מלסביות, שהופנמה בילדותה.

באמצעות בדיקה של המשמעויות האמיתיות והמופנמות של הלסביות, יכלה ליאורה להתחיל לגרש את השדים שרדפו אותה – הזעם, הבלבול, ותחושת הגועל (אותם חוותה כמצבי נתק רגשיים), שעד כה היו עמידים לניתוח ולשינוי. היא החלה לפתח חמלה חדשה לנפש בת התשע שלה. המקרה של ליאורה מתאר העברה נגדית על תהפוכותיה ויתרונותיה, תחילה כ"נקודה עיוורת" משותפת למטפלת ולמטופלת, ולאחר מכן כהארה וכפתרון לסוגיות של ליאורה.



נסרק עם CamScanner